



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : منى مصطفى محمد محمد
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : الشراييه
رقم البطاقة : 27608012702108 رقم التليفون : 01003801723
العمر (تاريخ الميلاد) : 01-08-1976 المهنة : ربه منزل
العنوان : 18 ش عباس الزيات
تاريخ تسجيل الإستمارة : 21-09-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان القولون
نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان القولون
خطة العلاج : جراحات أورام منظار قولون + عينه [13864] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: ----- التوقيع: -----
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: ----- التوقيع: -----
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: ----- التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : ----- قسم : -----
جهة العلاج : ----- نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: منى مصطفى محمد محمد National ID: 27608012702108	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

A patient of colon cancer for Colonoscopy with biopsy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
وزارة الداخلية

منى
مصطفى محمد محمد

١٨ شارع عباس الزيات
الشرابية - القاهرة

١٩٧٦/٠٨

٢٧٦٠٨٠١٢٧٠٢١٠٨

LB7724792

١- ٣٨٠/٧٢٣
١- ١٢٥/٦٩١



٢٠٢٥/٠٤ ٢٧٦٠٨٠١٢٧٠٢١٠٨

ربة منزل



أنثى مسلمة متزوجة
محمود مصطفى الصغير حسين احمد
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٤/٠٦

١



Name: Mona Moustafa Mohamed Mohamed
Referred by: Prof. Khaled Moustafa Al Kholi

ID: 5282281
Date: 09/08/2026

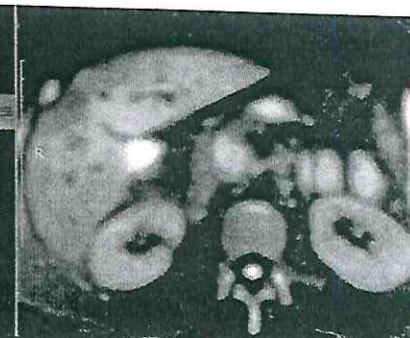
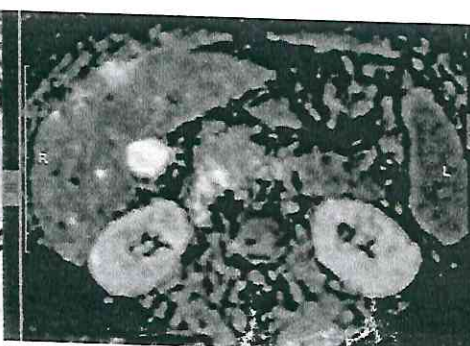
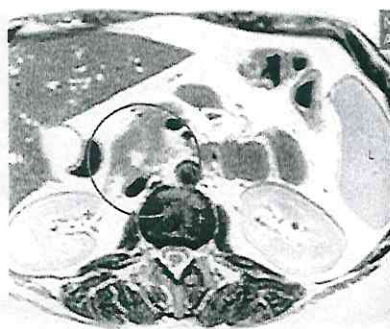
MR CHOLANGIOPANCRETOGRAPHY (MRCP)

MR TECHNIQUE:

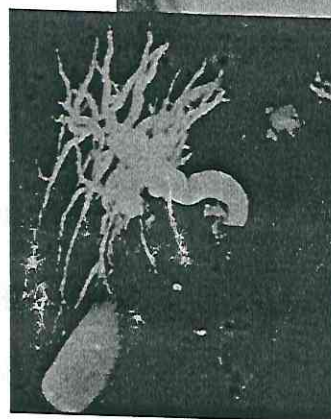
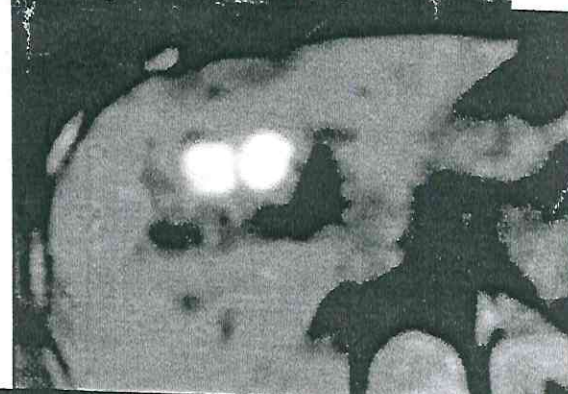
- Axial FSE/T2 and SPAIR images
- 2D and 3D heavy T2 MRCP images

(plates 1, 2).
(plates 3, 4).

MR FINDINGS:



- Moderate to marked dilatation of the intra and the extra hepatic biliary radicles with fusiform/lobulated appearance, associated sudden abrupt caliber change at the distal segment of the common bile duct about 2 cm from ampullar of vater. The CBD reached maximum axial diameter measuring 1.4 cm
- Poorly defined soft tissue lesion is seen epicentred upon the inferior aspect of pancreatic head/uncinate process showing diffusion restriction ; such lesion is seen partially insepararable from the 2nd part of the duodenum as well roughly measures about 1.8x1.4 cm
- No intra luminal filling defects seen within the dilated biliary channels.

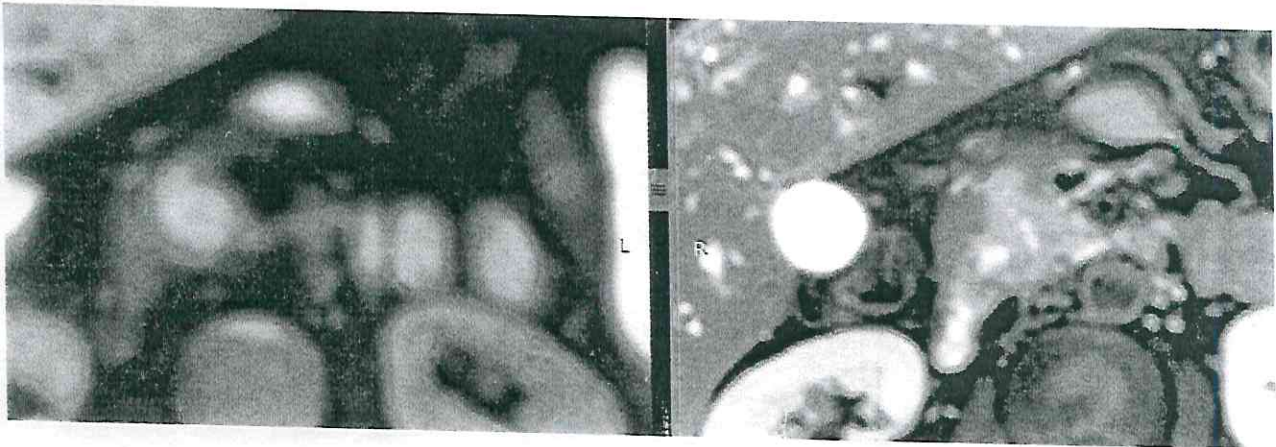


ID: 5282281

S C A N

- Two fairly defined hepatic focal lesions are noted within segment V and IVb measuring about 1.4 to 1.6 cm, they are seen eliciting low T1, high T2/SPAIR signal with peripheral diffusion restriction and surrounded by high parenchymal signal.
- The main pancreatic duct is mildly ectatic.
- Fluid level is noted within the distended gallbladder, likely attributed to sludge.

OPINION:



- Moderate to marked fusiform dilatation of the intra and extra hepatic biliary radicles as well as the CBD down to distal end that shows abrupt caliber tapering.
- Poorly defined soft tissue mass lesion seen epicentred upon inferior aspect of pancreatic head/uncinate process and partially inseparable from the duodenum showing diffusion restriction.
- Right hepatic lobe two well defined focal lesions; as described.

-Neoplastic process couldn't be ruled out for further dedicated assessment /further work up

Dr. Mohamed Ayman, MD

Dr. Sahar Saeed

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



منى
مصطفى محمد محمد

١٨ شارع عباس الزيات
الشرابية - القاهرة

١٩٧٦/٠٨

٢٧٦٠٨٠١٢٧٠٢١٠٨

LB7724792



Name: *Mona Moustafa Mohamed Mohamed*
 Referred by: *Prof. Khaled Moustafa Al Kholy*

ID: 5282281
 Date: 09/08/2026

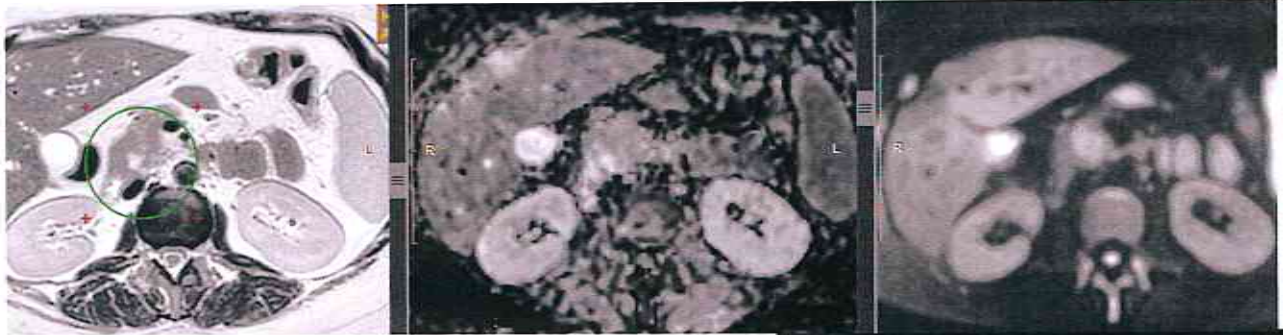
MR CHOLANGIOPANCRETOGRAPHY (MRCP)

MR TECHNIQUE:

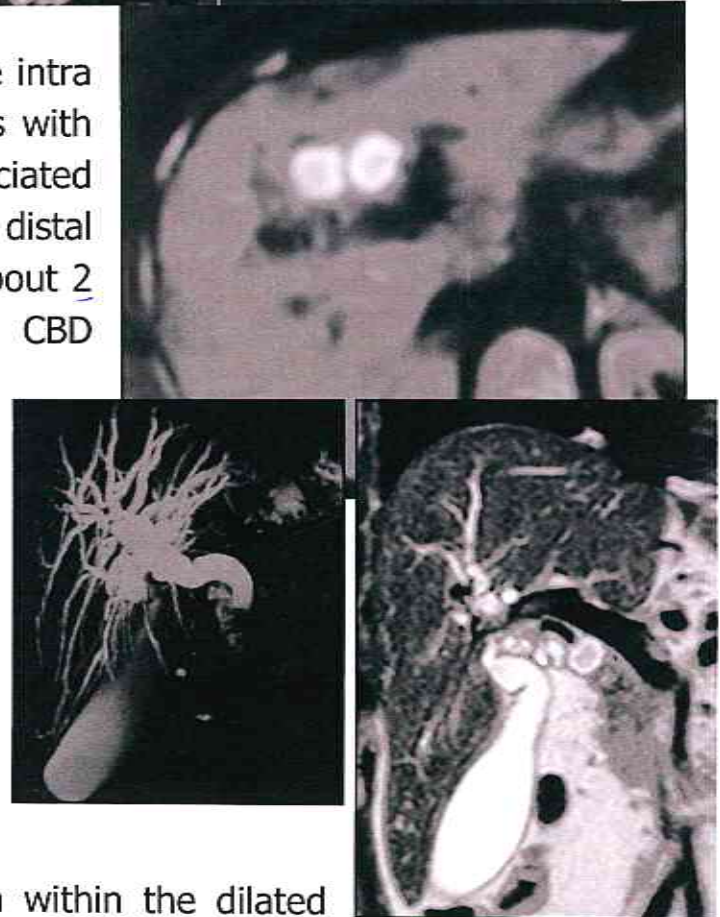
- Axial FSE/T2 and SPAIR images
- 2D and 3D heavy T2 MRCP images

(plates 1, 2).
 (plates 3, 4).

MR FINDINGS:



- Moderate to marked dilatation of the intra and the extra hepatic biliary radicles with fusiform/lobulated appearance, associated sudden abrupt caliber change at the distal segment of the common bile duct about 2 cm from ampullar of vater. The CBD reached maximum axial diameter measuring 1.4 cm
- Poorly defined soft tissue lesion is seen epicentred upon the inferior aspect of pancreatic head/uncinate process showing diffusion restriction ; such lesion is seen partially inseparable from the 2nd part of the duodenum as well roughly measures about 1.8x1.4 cm
- No intra luminal filling defects seen within the dilated biliary channels.

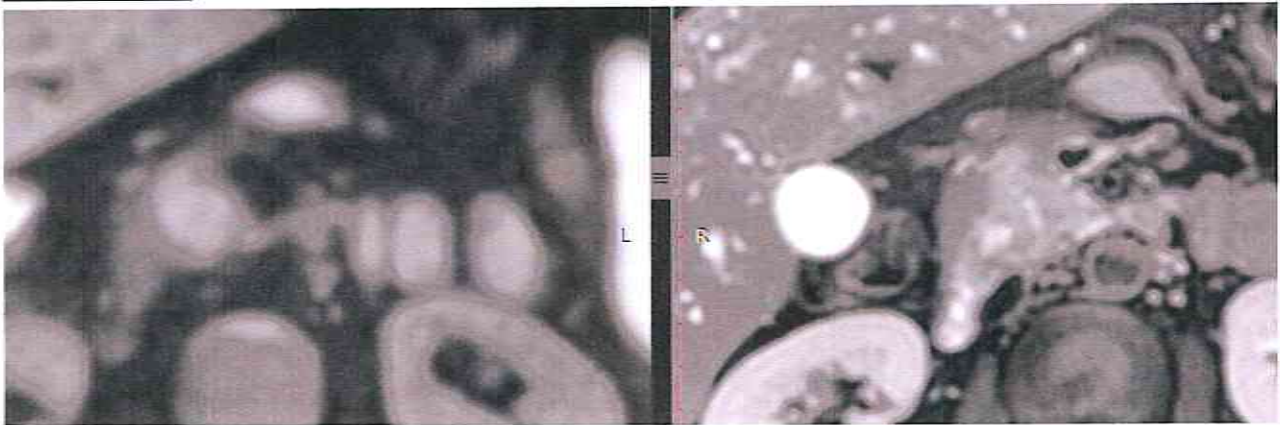




S C A N

- Two fairly defined hepatic focal lesions are noted within segment V and IVb measuring about 1.4 to 1.6 cm, they are seen eliciting low T1, high T2/SPAIR signal with peripheral diffusion restriction and surrounded by high parenchymal signal.
- The main pancreatic duct is mildly ectatic.
- Fluid level is noted within the distended gallbladder, likely attributed to sludge.

OPINION:



- **Moderate to marked fusiform dilatation of the intra and extra hepatic biliary radicles as well as the CBD down to distal end that shows abrupt caliber tapering.**
- **Poorly defined soft tissue mass lesion seen epicentred upon inferior aspect of pancreatic head/uncinate process and partially inseparable from the duodenum showing diffusion restriction.**
- **Right hepatic lobe two well defined focal lesions; as described.**

-Neoplastic process couldn't be ruled out for further dedicated assessment /further work up

Dr. Mohamed Ayman, MD

Dr. Sahar Saeed



الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي
و الأمراض المعوية
وحدة منظار الكبد و الجهاز الهضمي

ERCP Report

Name: مني مصطفى محمد

ID: 276080127022108

Date: Monday 17, August 2026

Age: 50

Referring Doctor

Dear Prof.

Thank you for referring the case.

Indications

Malignant obstructive jaundice.

Medications

General anesthesia.

Instrument

Pentax EPK i7010.

Procedure Technique

In the prone position. After adequate sedation was achieved the patient was intubated under direct visualization and the scope advanced to the D2.

Endoscopic Findings

- Major Papilla seen in place.
- Cannulation of the papilla was possible by precut incision.

Radiological Findings

- Injection of contrast revealed markedly dilated CBD and IHBRs with distal CBD tight stricture.
- Insertion of 10 Fr, 10 cm stent with good biliary drainage.

Recommendation

- EUS.

Conclusion

- Malignant obstructive jaundice.
- Distal CBD stricture with dilated CBD and IHBRs.
- Insertion of 10 Fr, 10 cm stent.

Dr Bassem Amin, FASGE.

إسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

تقرير طبي

...../المسيد/.....

تحية طبية وبعد،،

إيماء الطلب المقدم من بشأن تقرير طبي للمريض:

يقسم رقم طبي

تتشرف بأن أوضح فيما يلي تقريراً عن حالته:

تاريخ وساعة الدخول تاريخ وساعة الخروج

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

The pt is known to have metastatic disease of unknown: try for routine lab investigations before starting therapy.
المريض من بعد لزاماً وبجانب نتائج ونتائج لعل
تأليق وخصوصاً للتطعيمات منظاراً، مقرر لعل

تحريراً في

الوقت:

التاريخ:

21/9/2024

الطبيب المعالج

د. أيمن محمد

يعتمد،،

اسم المريض ثلاثي: هـ. هـ. هـ.
رقم الملف:

تقرير طبي

...../ السيد/

تحية طبية وبعد،

إيماء لطلب المقدم من بشأن تقرير طبي للمريض:

بقسم رقم طبي

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول تاريخ وساعة الخروج

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:
the pt is known to have infective aetiology.

المريض يعاني من حمى وصداع وتقيح ليل
معتدل، فلوليت للصبغ في سبيل اليوم.

تحريراً في

الوقت: التاريخ: / /

21/9/2026

الطبيب المعالج
د. أحمد محمد

يُعتقد،